

REPASO TERMINOLOGÍA EA3

sábado, 13 de junio de 2026

16:20

SISTEMA DE SALUD: REDES Y NIVELES DE ATENCIÓN

El sistema chileno se organiza como una **Red Integrada de Servicios de Salud (RISS)**, estructura por niveles de complejidad creciente:

- **Nivel Primario (APS):** Es la **puerta de entrada** al sistema.
Enfoque: Preventivo y promocional.
Centros: CESFAM, CECOSF, Postas Rurales.
Resolutividad: Debe resolver más del **85% de las consultas**.
Urgencias APS: SAPU (baja complejidad) y SAR (alta resolutividad con Rayos X y Laboratorio básicos).
- **Nivel Secundario (Especialidad):** Actúa como centro de referencia para casos que la APS no resuelve.
Atención Abierta: Realizada en CDT (Centros de Diagnóstico terapéutico) o CRS (Centro de Referencia de Salud) mediante interconsultas.
Atención Cerrada: Hospitales con las 4 especialidades básicas (Medicina Interna, Cirugía, Pediatría y Ginecología-Obstetricia).
- **Nivel Terciario (Alta Complejidad):** Máxima capacidad resolutiva tecnológica y clínica para casos graves.
Centros: Hospitales regionales e Institutos nacionales (ej: Instituto del Tórax).
Unidades: UCI, Pabellones de Neurología o Trasplantes, e Imagenología avanzada.

ÁREAS CRÍTICAS Y SUS REQUERIMIENTOS

- **Urgencias ("El Caos Organizado"):** Su flujo crítico es:
Admisión -> Triage (categorización) -> Atención -> Destino.
Triage ESI: Índice de severidad de emergencia.
ESI 1: Riesgo vital inminente (atención inmediata).
ESI 2: Paciente en situación de alto riesgo (30 min.).
ESI 3: Paciente estable que requiere **múltiples recursos**.
ESI 4: Paciente estable que requiere **un solo recurso**.
ESI 5: Paciente no urgente (atención general).
- **Unidad de Paciente Crítico (UPC):** Incluye la UCI (Cuidados Intensivos) y UTI (Cuidados intermedios).
Infraestructura: Requiere redundancia eléctrica (UPS), gases clínicos y monitores conectados a una central.
- **Pabellones Quirúrgicos:** Zonas estériles de alta complejidad.
Gestión Informática: Requiere **Tabla Quirúrgica Electrónica**, trazabilidad de insumos (costos) y **Protocolo Operatorio Digital**.

ÁREAS DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEÚTICO

Estas áreas son el "corazón tecnológico" y son vitales para la informática biomédica:

- **Laboratorio Clínico:** El **70% de las decisiones médicas** se basan en sus resultados.
Sistemas: Usa el **LIS (Sistema de Información de Laboratorio)** e interoperabilidad vía **HL7** para enviar resultados a la ficha clínica.
- **Farmacia Hospitalaria:** Garantiza el suministro seguro de fármacos.
Seguridad: Utiliza la **Receta Electrónica** y la **Administración segura de pie de cama** (verificando pacientes, dosis y medicamento correcto mediante código de barras).
- **Imagenología:** Obtiene e interpreta imágenes médicas.
Sistemas clave: **RIS** (Gestión de agendas y flujos) y **PACS** (almacenamiento y distribución de imágenes).
Estándar: Utiliza el estándar **DICOM** para el manejo de imágenes.
- **Central de Esterilización:** Clave para el control de **IAAS** (Infecciones Asociadas a la Atención de Salud).
Relevancia Informática: Permite la **trazabilidad** (saber en qué paciente se usó que instrumental y si el ciclo de autoclave fue correcto).

TRASPASO CLÍNICO Y TÉCNICA SBAR.

En el flujo de hospitalización, el traspaso de información entre equipos es crítico para la seguridad. Las fuentes mencionan el uso de la **técnica SBAR** (Situación, Antecedentes, Evaluación y Recomendación) como un formato estructurado para asegurar la continuidad del cuidado durante el traslado del paciente.

GESTIÓN DE CAMAS Y DERIVACIÓN.

Cuando un hospital no tiene camas disponibles.

- Interviene la **Unidad de Gestión de Camas**.
- Si la red propia está saturada, se gestiona la **derivación intrarred o extrarred** (a otros hospitales o clínicas).

FLUJO DE TRABAJO Y "EL VIAJE DEL PACIENTE"

El flujo operativo es la columna vertebral de la atención y debe estar estandarizado para garantizar calidad.

- **Admisión y Agendamiento:** Incluye la identificación del paciente, verificación de citación y **validación previsional** (financiamiento).
- **Preparación Pre-Clinica:** Realizada por un TENS; incluye toma de **signos vitales y antropometría** (peso/talla: IMC) ingresados directamente al RCE (Registro Clínico Electrónico).
- **Atención Médica:** Consta de anamnesis, examen físico, hipótesis diagnóstica y generación de documentos (recetas, licencias).
- **Hospitalización:** Requiere gestión de camas en tiempo real (censo diario) y coordinación para traslados.

GESTIÓN DE ACTIVOS E INFRAESTRUCTURA

- **Infraestructura Moderna:** No es solo el edificio; es una plataforma operativa donde convergen el espacio físico, el equipamiento y los **flujo de información**.
- **Desincorporación (baja) de equipos:** Criterios para dar de baja tecnología:
 1. Obsolescencia tecnológica.
 2. Costo de reparación >50-60% del valor nuevo.
 3. Falta de repuestos.
- 4. **Seguridad de datos:** Es obligatorio el borrador seguro de discos duros con datos de pacientes antes de desechar el equipo.

CONCEPTOS CLAVES DE INTEROPERABILIDAD

- **HL7/FHIR:** Para datos clínicos y mensajes.
- **DICOM:** Para imágenes médicas.
- **RCE / HIS:** El núcleo donde se centraliza toda la información del paciente.

CUESTIONARIO PROFE

1. **¿Qué se entiende por flujo de trabajo en un institución sanitaria?**
Es la secuencia de pasos y procesos (administrativos y clínicos) que se siguen desde que un paciente ingresa al sistema hasta que se retira, permitiendo la coordinación entre los distintos profesionales y unidades.
2. **¿Qué son las redes integradas de servicio de salud (RIS)?**
organizaciones que prestan o hacen arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población definida, coordinando los distintos niveles de atención.
3. **¿Cuáles son los tres niveles de atención asistencial?**
Primario: El primer contacto, enfocado en promoción y prevención (ej. CESFAM).
Secundario: Atención de especialistas y diagnóstico más complejo (ej. Centros de Diagnóstico y Tratamiento - CDT).
Terciario: Hospitalización, cirugías complejas y cuidados críticos.
4. **¿Por qué se espera que la aps resuelva la mayoría de las consultas de salud?**
Resolución de la APS: Se espera que la Atención Primaria de Salud resuelva la mayoría de las consultas (aproximadamente el 80%) porque aborda las patologías más prevalentes mediante un enfoque preventivo y cercano a la comunidad.
5. **¿Cuál es la función del cesfam?**
Centro de Salud Familiar cuya función es brindar atención integral con enfoque familiar y comunitario, centrada en la prevención y promoción de la salud.
6. **Diferencia entre sapu y sar.**
SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia): Atiende urgencias de baja complejidad.
SAR (Servicio de Alta Resolutividad): Es una evolución del SAPU; cuenta con mayor capacidad diagnóstica (como rayos X y laboratorios básicos) y suele funcionar en horarios extendidos para evitar colapsos en hospitales.
7. **Características del nivel secundarios.**
Se caracteriza por ofrecer atención ambulatoria de especialidad, apoyo diagnóstico y terapéutico que no puede ser resuelto en la APS, pero que no requiere necesariamente hospitalización de alta complejidad.
8. **¿Qué px son atendidos en el nivel terciario?**
Aquellos que requieren intervenciones quirúrgicas complejas, cuidados críticos (UCI/UTI), o tratamientos de alta tecnología y especialización.
9. **Describe las etapas del proceso de agendamiento y admisión del px.**
Agendamiento: Solicitud de hora, verificación de disponibilidad y asignación de la cita.
Admisión: Identificación del paciente, verificación de su previsión (FONASA/Isapre) y registro del ingreso al sistema para la atención.
10. **¿Qué información se registra durante la preparación preclínica?**
Se registra información como signos vitales (presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura), peso, talla y, a veces, el motivo principal de la consulta antes de que el paciente vea al médico.

CUESTIONARIO PROFE

11. **¿Qué actividades forman parte de la anamnesis? ¿Qué es?**
Es el proceso de la entrevista clínica donde el profesional de salud recopila la historia médica del paciente, sus síntomas actuales, antecedentes familiares y hábitos.
12. **¿Qué documento se generan al finalizar una consulta médica, ambulatoria, urgencia y hospitalaria?**
Ambulatoria: Recetas médicas, órdenes de exámenes e interconsultas.
Urgencia: Hoja de atención de urgencia (DAU) y recetas.
Hospitalaria: Epicrisis (resumen del alta).
13. **¿Cuál es el objetivo de triage?**
Clasificar a los pacientes según su gravedad clínica y riesgo vital para priorizar la atención, asegurando que los casos más urgentes sean atendidos primero, independientemente del orden de llegada.
14. **¿Cuál es la diferencia entre las categorías de ESI?**
Índice de Severidad de Emergencia.
ESI 1: Riesgo vital inmediato (Atención inmediata).
ESI 2: Alta complejidad/Inestabilidad potencial (10-15 min con un máx. de 30 min).
ESI 3: Estable, pero requiere múltiples recursos (30-90 min).
ESI 4: Baja complejidad (120-180 min).
ESI 5: No urgente.
15. **¿Qué ocurre cuando no existen camas disponibles para hospitalizar?**
Se activa la gestión de camas, lo que puede derivar en el traslado del paciente a otro centro de la red (público o privado) mediante la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC).
16. **¿Cuál es la función del HIS?**
Sistema de Información Hospitalaria: Gestionar de forma integrada todos los aspectos administrativos, financieros y clínicos de un hospital.
17. **¿Cuál es la diferencia del HIS y el RCE?**
El **HIS** es el sistema global de gestión del hospital (incluye contabilidad, farmacia, etc.), mientras que el **RCE** (Registro Clínico Electrónico) es el componente específico donde se documenta la atención clínica del paciente (la ficha médica digital).
18. **¿Qué función cumple LIS y RIS/PACS?**
LIS (Sistema de Información de Laboratorio): Gestiona los procesos y resultados del laboratorio clínico.
RIS/PACS: El **RIS (Sistema de Información Radiológica)** gestiona la agenda y flujos de radiología, mientras que el **PACS (Sistema de Archivamiento y Comunicación de Imágenes)** almacena y permite visualizar las imágenes digitales (Rayos X, Scanner, etc.).
19. **¿Qué es interoperabilidad?**
Es la capacidad de diferentes sistemas de información y aplicaciones de software para comunicarse, intercambiar datos y utilizar la información que ha sido intercambiada de manera precisa y efectiva.

CUESTIONARIO

1. **¿Cuál es la definición contemporánea de infraestructura en el contexto sanitario?**
Una plataforma operativa donde convergen el espacio físico, equipamiento biomédico y flujos de información. Esta visión integra lo físico con lo tecnológico y lo informativo como un todo operativo para el éxito de la salud digital.
2. **En el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud(RISS) ¿Cuál es la lógica principal que determina la jerarquía física y de datos?**
Niveles de complejidad creciente. El sistema se organiza para el paciente progrese desde la menor a la mayor complejidad tecnológica según su necesidad clínica.
3. **¿qué porcentaje de las consultas de salud de la población se estima que debe resolver el APS?**
Más del 85%. La alta capacidad resolutoria en la base del sistema es clave para evitar el colapso de los hospitales de mayor complejidad.
4. **Dentro de los dispositivos de urgencia en APS ¿Qué característica distingue principalmente al SAR del SAPU?**
El SAR posee mayor capacidad resolutoria al contar con Rayos X y exámenes de laboratorio básicos. Se diseñó precisamente para resolver urgencias intermedias sin derivar inmediatamente al hospital.
5. **En el "Patient Journey" ¿Qué dimensión se encarga de gestionar el "con qué" y el "cuando" de la atención?**
El área administrativa. La administración orquesta los recursos y el financiamiento para que el acto clínico sea viable en el tiempo correcto.
6. **¿Cuál es la función del Comité de Gestión de la Demanda en el nivel secundario de atención?**
Revisar y priorizar las interconsultas enviadas desde el cesfam. Este comité actúa como filtro y organizador para asegurar que los especialistas atiendan los casos más urgentes o pertinentes.
7. **¿Qué unidad funcional dentro de un hospital se define por atender pacientes con riesgo vital y requerir redundancia eléctrica y de datos?**
Áreas críticas (ups, urgencias). La alta dependencia tecnológica y el riesgo vital exigen sistemas de soporte vital y de información con falla cero.
8. **En el proceso de agendamiento y admisión ¿Qué estado indica que el paciente ya está disponible físicamente para ser atendido?**
Estado presente. Este cambio de estado en el sistema notifica al clínico que el paciente ha completado su validación administrativa.
9. **¿Cuál es el objetivo primordial del proceso de Preparación Pre-Clinica realizado por el tens?**
Recopilar datos antropométricos y signos vitales para la FCE. Este proceso ahorra tiempo al médico y proporciona una base de datos objetivos (como el imc y presión arterial) antes de la consulta.
10. **Durante el acto médico ¿Qué paso garantizar la correcta vinculación entre el paciente físico y su registro digital?**
Identificación de seguridad (nombre y run). Confirmar la identidad verbalmente y compararla con el sistema evita errores críticos de registro y medicación.
11. **En el nivel secundario de atención ¿Cómo se denomina el tipo de servicio realizado en CDT o CRS?**
Atención abierta. Se refiere a servicios donde el paciente no requiere pernoctar en el hospital y regrese a su domicilio tras la consulta.
12. **¿Qué caracteriza a un hospital de nivel terciario en la red asistencial?**
Máxima capacidad resolutoria tecnológica, incluyendo institutos nacionales. El nivel terciario centraliza las especialidades más complejas y costosas, como trasplantes y medicina nuclear.
13. **Bajo el protocolo de priorización ESI ¿Qué clasificación recibe un paciente estable que requiere múltiples recursos para su diagnóstico o tratamiento?**
ESI 3. Este nivel identifica pacientes que no tienen riesgo vital pero cuya condición es compleja y consume tiempo y recursos hospitalarios.

14. **¿Qué herramienta se utiliza para asegurar la continuidad del cuidado durante el traslado intraestablecimiento del paciente?**
Traspaso clínico estructurado (ej: técnica SBAR). El formato SBAR permite comunicar de forma estandarizada la situación, antecedentes, recomendaciones del paciente.
15. **¿Cuál es la función de la unidad de gestión de camas(UGC)?**
Buscar y priorizar la disponibilidad de camas según la gravedad del paciente. La UGC optimiza el uso del recurso cama, coordinando ingresos desde urgencias y derivaciones externas.
16. **¿Por qué se afirma que la gestión administrativa es una herramienta de seguridad del paciente?**
Porque fallas en la identificación o validación repercuten en errores clínicos directos. Un error en el ingreso de datos puede llevar a administrar medicamentos al paciente equivocado o a una derivación errónea.
17. **¿Qué cambio normativo reciente permite y regula la atención de salud a distancia en Chile?**
Ley n° 21.541 Ley de Telemedicina. Esta ley entrega el marco legal para que las prestaciones a distancia tengan la misma validez que las presenciales.
18. **En la jerarquía de niveles de atención ¿Cuál es el objetivo de que el paciente ingrese por el nivel más bajo?**
Garantizar una mayor cobertura territorial y optimizar los recursos especializados. La APS es más accesibles geográficamente y filtra los casos para que los hospitales no se saturen con problemas simples.
19. **¿Qué documento es esencial para que un paciente del nivel primario sea atendido por un especialista en el nivel secundario?**
Interconsultas (SIC). La solicitud de interconsultas es el puente de comunicación que justifica y solicita la evaluación de especialidad.
20. **¿Qué elemento debe ser el "eje central" para la optimización del flujo de trabajo?**
El recorrido del paciente (patient journey). Organizar los servicios en torno a la experiencias del usuario permite eliminar barreras burocráticas y duplicidad de trámites.
21. **¿Cuál es la función principal del área de apoyo (farmacia, laboratorio) en la lógica de datos?**
Proporcionar resultados diagnósticos y terapéuticos que alimentan la toma de decisiones clínicas. Estas unidades generan datos críticos que deben integrarse rápidamente en la ficha del paciente para su tratamiento.
22. **En el proceso de ingreso clínico ¿Qué componente se encarga de monitorear el progreso del paciente las 24 horas del día?**
Plan de cuidados de enfermería. Enfermería asegura la continuidad de los cuidados y la valoración constante durante toda la estadía hospitalaria.
23. **¿Qué clasificación ESI le correspondería a un paciente que presenta riesgo vital inminente?**
ESI 1. Identifica pacientes que requieren reanimación inmediata debido a la inestabilidad extrema de sus signos vitales.
24. **Dentro de la arquitectura de información clínica ¿Qué sistema permite la integración de la gestión de camas y las agendas?**
Sistema de salud digital (FCE e interoperabilidad). La digitalización permite que la información de disponibilidad de recursos sea visible en tiempo real para toda la red.
25. **¿Cuál es la función del proceso de "egreso y cierre administración"?**
Finalizar el episodio de atención en el sistema y entregar indicaciones al paciente. Este paso asegura que el ciclo se cierre correctamente tanto clínica como administrativamente para liberar recursos.
26. **En el contexto de la red asistencial ¿Qué significa que la relación entre áreas clínicas y administrativas sea simbólica?**
Que ambas dependen mutuamente para lograr una atención fluida, segura y humanizada. El éxito de la atención médica no es un esfuerzo aislado de un solo sector, sino de la orquestación de ambos.
1. **Explique por qué la APS es considerada la puerta de entrada al sistema de salud.**
Se considera así porque es el primer punto de contacto de la población con el sistema de salud, diseñado para ser accesible y brindar una atención integral y continua.
2. **¿Cuáles son las principales diferencias entre el nivel primario, secundario y terciario de atención?**
Primario: Se enfoca en promoción, prevención y resolución de problemas frecuentes de baja complejidad.
Secundario: Brinda atención ambulatoria especializada y procedimientos de mediana complejidad.
Terciario: Atiende patologías de alta complejidad que requieren hospitalización, tecnología avanzada y especialistas.
3. **¿Por qué se espera que la APS resuelva más del 85% de las consultas de salud?**
Se espera este porcentaje porque la APS debe resolver la gran mayoría de las consultas por problemas de salud de alta prevalencia y baja complejidad, evitando así que los hospitales (niveles secundario y terciario) se saturen innecesariamente.
4. **Describe una situación clínica que requiera derivación desde APS hacia atención secundaria.**
Un ejemplo sería un paciente hipertenso controlado en APS que comienza a presentar signos de insuficiencia cardíaca o daño renal, requiriendo ser evaluado por un especialista (cardiólogo o nefrólogo) en el nivel secundario.
5. **Mencione dos características exclusivas del nivel terciario de atención.**
Incluye el uso de tecnología médica de alta complejidad y la realización de intervenciones quirúrgicas mayores o tratamientos altamente especializados.
6. **Describe el recorrido completo de un paciente desde que solicita una hora hasta el cierre de su atención.**
Comienza con la solicitud de hora, sigue con la admisión (identificación), pasa a la preparación preclínica (TENS), luego al acto clínico (médico), posibles exámenes auxiliares, y finaliza con el cierre de la atención o una derivación.
7. **¿Por qué la validación de identidad es una etapa crítica en la admisión?**
Es crítica para garantizar la seguridad del paciente, asegurando que la información clínica y los tratamientos se asignen a la persona correcta, evitando errores médicos.
8. **¿Qué información debe verificarse durante el proceso de admisión?**
Debe verificarse la identidad del paciente (nombre, RUT), sus datos de contacto, previsión de salud y motivo de consulta.
9. **¿Qué actividades realiza el TENS durante la preparación preclínica?**
Realiza la preparación preclínica, que incluye el control y registro de signos vitales (presión arterial, pulso, temperatura, etc.) y antropometría.
10. **¿Cuál es la importancia de registrar los signos vitales en la ficha clínica electrónica?**
Es fundamental para proporcionar una base objetiva del estado de salud del paciente al médico y permitir el seguimiento histórico en la ficha electrónica.
11. **Explique cuál es el objetivo del sistema de triage.**
Su fin es clasificar y priorizar a los pacientes según su gravedad clínica y riesgo vital, en lugar de atender por orden de llegada.
12. **Compare las categorías ESI 1 y ESI 5.**
ESI 1: Es una emergencia con riesgo vital inmediato que requiere reanimación.
ESI 5: Es una condición no urgente que podría ser resuelta en el nivel primario de atención.

2° CUESTIONARIO PROFE

13. **¿Qué criterios pueden determinar la necesidad de hospitalizar a un paciente?**
Incluyen la necesidad de monitoreo continuo, administración de tratamientos intravenosos complejos o intervenciones quirúrgicas que no pueden ser ambulatorias.
14. **¿Cuál es la función de la Unidad de Gestión de Camas?**
Se encarga de optimizar el uso de las camas hospitalarias, coordinando ingresos, traslados y altas para asegurar un flujo eficiente de pacientes.
15. **¿Qué acciones deben realizarse cuando no existen camas disponibles en un establecimiento?**
Si no hay disponibilidad, se debe gestionar el traslado del paciente a otro establecimiento de la red (pública o privada) que cuente con el recurso necesario.
16. **Explique la diferencia entre HIS y Ficha Clínica Electrónica.**
El HIS es el sistema integral que gestiona lo administrativo y clínico de un hospital; la Ficha Clínica Electrónica es el registro digital específico de la historia clínica de un paciente.
17. **¿Qué información genera un sistema LIS?**
El sistema de laboratorio genera resultados de exámenes, valores de referencia y trazabilidad de las muestras biológicas.
18. **¿Cuál es la función de RIS y PACS dentro de Imagenología?**
El RIS gestiona el flujo de trabajo y los informes de radiología; el PACS se encarga del almacenamiento y visualización de las imágenes médicas digitales.
19. **¿Por qué la interoperabilidad es fundamental para la atención sanitaria?**
Es fundamental porque permite que distintos sistemas (como LIS, RIS y FCE) compartan datos, asegurando que el equipo de salud tenga la información completa del paciente en cualquier momento y lugar.
20. **Describe cómo fluye la información de un examen de laboratorio desde la solicitud médica hasta la visualización del resultado.**
Inicia con la orden médica en la Ficha Electrónica, viaja al LIS para el procesamiento, los resultados se validan en el LIS y se transmiten de vuelta para ser visualizados por el médico.
21. **¿Qué riesgos puede generar una identificación incorrecta del paciente?**
Puede provocar administración de medicamentos erróneos, cirugías en el sitio equivocado, diagnósticos cruzados y riesgos graves para la vida del paciente.
22. **Explique la importancia de la trazabilidad en los sistemas de salud.**
Es clave para seguir el historial y ubicación de un insumo o el trayecto de atención de un paciente, facilitando el control de calidad y la investigación de errores.
23. **¿Qué medidas de seguridad informática protegen la información clínica?**
Se utilizan medidas como la autenticación de usuarios (claves), encriptación de datos, perfiles de acceso restringidos y registros de auditoría para proteger la información confidencial.
24. **Mencione tres problemas que podría detectar un profesional de Informática Biomédica durante el flujo de atención.**
Pueden identificar fallas en la interoperabilidad entre sistemas, interfaces de usuario poco usables que causan errores de registro o cuellos de botella en el flujo digital de resultados.